

골다공증 약과 치과 시술, 약을 꼭받는 것이 답이 아닙니다

필요한 치과 치료를 미루는 것이 오히려 위험할 수 있습니다 — 가장 중요한 것은 약 이름과
마지막 주사 날짜입니다

먼저 결론 — 세 가지만 기억하세요

골다공증 약을 쓰는 분도 대부분의 치과 치료를 그대로 받을 수 있습니다



1

필요한 치과 치료는 받습니다

스케일링·충치 치료·신경 치료는 약과 상관없이 받습니다. 굵은 이를 그대로 두는 쪽이 턱뼈에는 **더 나쁩니다**.

턱뼈 문제가 생긴 분들은 이미 굵은 이를 뽑은 경우가 많았습니다.

치과를 미루지 않기



2

약은 스스로 끊지 않습니다

먹는 약은 두세 달 쉬어도 뼈에서 빠지지 않고, 프롤리아는 늦어지면 **척추 골절**이 일어납니다. 조정은 내과에서 정합니다.

쉬는 동안 골절을 막는 힘만 줄어듭니다.

끊기 전에 내과와 상의



3

약 이름과 마지막 주사 날짜를 알립니다

'골다공증약'이라는 말만으로는 치과가 판단할 수 없습니다. **약봉투나 처방전**을 그대로 보여 주시면 가장 정확합니다.

같은 '주사'라도 골다공증용과 암 치료용은 전혀 다릅니다.

약봉투 사진 한 장

Tip · 치과 예약이 잡히면 내과에 먼저 알려 주세요. 약 종류에 따라 시점을 함께 맞춥니다.

근거 · AAOMS 2022 권고안

기준은 하나 — 그 치료가 뼈를 건드리는가

뼈를 건드리지 않는 치료는 약과 상관없이 받습니다

약 조정 없이 받는 치료

뼈를 건드리지 않는 치료입니다. **평소처럼** 받으십시오.

- 스케일링·잇몸 관리
- 충치 치료·때우기
- 신경 치료(뿌리 치료)
- 틀니 조정 — 잇몸이 혈면 **바로** 고칩니다

VS

뼈를 건드리는 치료

못 하는 것이 아니라 **계획**이 필요합니다. 내과에 먼저 알려 주세요.

- 이 뽑기(발치)
- 임플란트
- 잇몸 뼈 수술·뼈 이식
- 먹는 약은 대개 그대로 · 프롤리아는 **주사 날짜**에 맞춰 계획

Tip · 약을 끊을지 묻기 전에, 받을 치료가 뼈를 건드리는지부터 확인합니다.

근거 · AAOMS 2022 권고안

턱뼈 괴사가 무엇인가요

잇몸이 아물지 않고 턱뼈가 드러난 상태 — 이를 뽑지 않았어도 생길 수 있습니다

▲ 세 가지가 모두 맞을 때

① 골다공증약이나 항암용 뼈 주사를 쓴 적이 있고 ② 턱뼈가 드러나거나 잇몸 구멍으로 뼈가 만져지는 상태가 **8주** 넘게 이어지고 ③ 턱 방사선 치료를 받은 적이 없을 때입니다.

🗑️ 드문 일입니다

골다공증 용량에서는 **드물게** 생깁니다. 암 치료용 고용량 주사를 맞는 분들에서는 훨씬 흔합니다.

👤 이럴 때는 진료를 받으세요

뽑은 자리가 몇 주째 낫지 않거나, 이를 뽑지 않았어도 턱이 계속 아프고 뼈가 만져지면 치과 진료를 받으세요.



그림 · 이를 뽑은 자리가 아물지 않고 뼈가 드러난 모습 — 8주 넘게 이어지면 턱뼈 괴사로 봅니다(설명용 그림).

근거 · AAOMS 2022 권고안

약마다 턱뼈 문제의 크기가 다릅니다

골다공증 용량에서는 1만 명당 몇 명 — 암 치료용 주사만 자릿수가 다릅니다

약	어떤 약인가	턱뼈 문제가 생기는 수	치과 치료 전에
약을 쓰지 않는 분	비교 기준	1만 명당 0~2명	—
먹는 골다공증약	알렌드로네이트 등 · 매주·매달 먹는 약	1만 명당 2~5명	대개 계속 드십니다 · 설지는 처방 의사가 정함
1년에 한 번 맞는 주사	졸레드론산 · 1년에 1회	1만 명당 2명 이하 (자료마다 다름)	마지막 주사 날짜를 알리고, 시술 시점과 다음 주사를 함께 정함
프롤리아	6개월마다 맞는 주사	1만 명당 4~30명	마지막 주사 날짜로 시점 계획
암 치료용 뼈 주사	4주마다 · 골다공증 용량의 수십 배	100명 중 1~15명	암 담당 주치의와 먼저 상의

Tip · 프롤리아를 맞으며 이를 뽑은 분만 모으면 427명 중 10명(2.3%) — 누구를 세느냐에 따라 숫자가 달라집니다.

근거 · AAOMS 2022 · Colella 2023

위험을 키우는 것 — 약보다 '입안 감염'

굵은 이를 그대로 두는 것이 가장 큰 문제입니다

가장 흔한 계기는 발치

턱뼈 문제가 생긴 분들을 되짚어 보면 이를 뽑은 일이 앞선 경우가 가장 많았습니다. 다만 그 이가 이미 굵아 있던 탓도 큼니다.

입안에서 살펴볼 것

잇몸병(치주염) · 뿌리 끝 굵음 · 임플란트 주위 염증 · 잇몸을 계속 헐게 하는 안 맞는 틀니.

몸 쪽에서 겹치는 것

스테로이드를 오래 쓰는 경우, 당뇨, 콩팥병, 흡연, 고령이 겹치면 상처가 더디 아뉘니다.

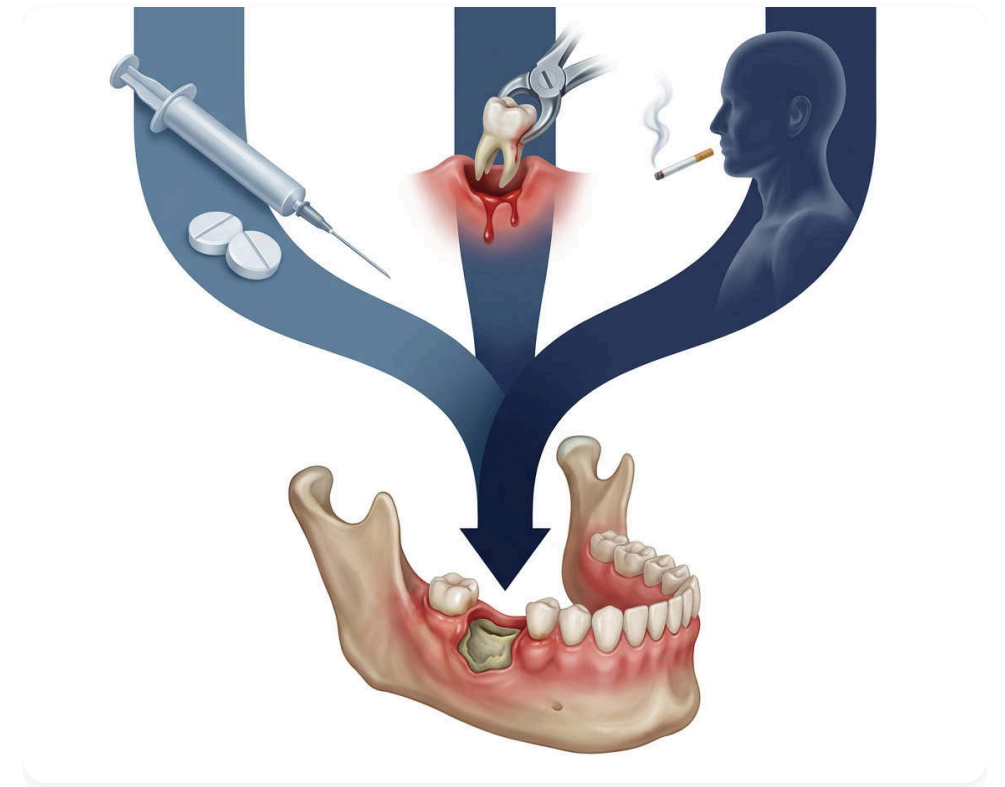


그림 · 약·입안 감염·몸 상태 세 갈래가 한 자리에서 만날 때 턱뼈 문제가 됩니다(설명용 그림).

근거 · AAOMS 2022 권고안

먹는 약과 프롤리아는 반대로 움직입니다

그래서 치과 치료 앞에서 대처도 반대입니다

먹는 골다공증약

뼈에 달라붙어 **수년 동안** 남습니다.

- 두세 달 쉬어도 뼈 안의 약은 그대로입니다
- 쉰 분과 계속 드신 분의 차이가 연구에서 확인되지 않았습니다
- 쉬는 동안 골절을 막는 힘만 줄어듭니다
- **스스로 끊지 않습니다** — 오래 드셨거나 위험 요인이 있으면 쉴지 여부는 처방 의사와 치과가 함께 정합니다

VS

프롤리아(6개월 주사)

뼈에 쌓이지 않고 **몸에서 빠져나갑니다.**

- 주사가 늦어지면 뼈가 빠르게 약해지는 '반동'이 옵니다
- 반동은 척추 골절로 나타납니다 — 다음 장
- 그래서 치료 시점을 주사 날짜에 맞춥니다
- **끊지 말고 시점을 맞춥니다**

Tip · 치과에서 '몇 달 끊고 오세요'라고 하면, 약 이름부터 알려 주십시오.

근거 · 메타분석 8편·6,808명 · AAOMS 2022

프롤리아를 오래 미루면 척추가 한꺼번에 무너질 수 있습니다

턱뼈 문제보다 흔하고, 한 번에 여러 마디가 옵니다

숫자로 보면

주사를 끊으면 척추 골절이 100명당 1년에 **1.2건에서 7.1건**으로 늘었습니다.

여러 마디가 함께

그때 생긴 척추 골절의 **61%**가 여러 마디였습니다. 키가 줄고 등이 굽기도 합니다.

특히 조심할 분

이미 척추 골절을 겪은 적이 있으면 여러 마디가 함께 무너질 위험이 **약 3.9배**였습니다.

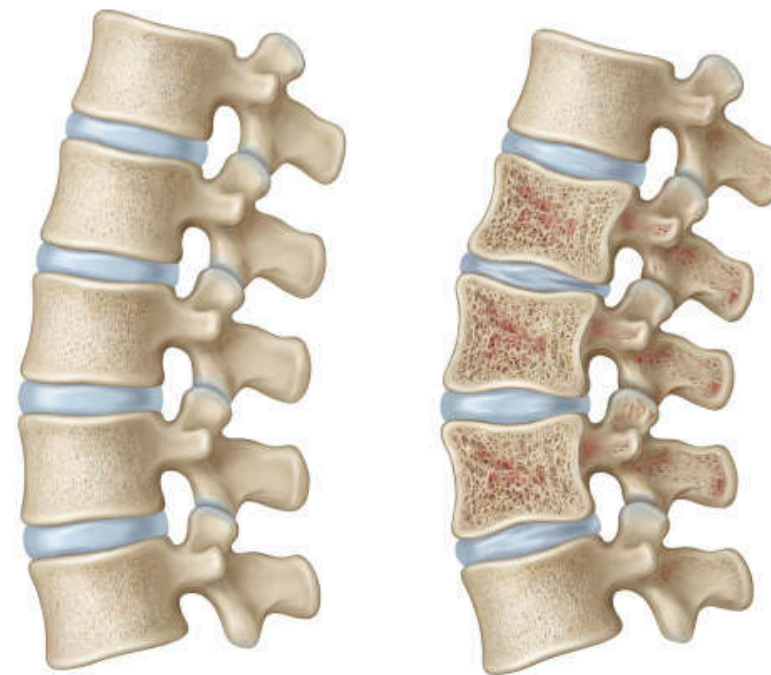


그림 · 왼쪽에 견주어 오른쪽은 여러 마디가 납작하게 내려앉았습니다(설명용 그림).

근거 · Cummings 2018

발치는 마지막 주사 뒤 3~4개월

프롤리아를 맞는 분 — 주사와 주사 사이를 왼쪽에서 오른쪽으로 펼쳤습니다



주사 직후

주사 힘이 가장 셀 때

3~4개월 뒤

이를 뽑기 가장 무난한 때

너무 미루면

척추 골절 위험이 오르는 때

Tip · 5개월이 지났다면 더 기다리지 말고 내과·치과가 발치와 다음 주사 날짜를 함께 정합니다. 아프거나 굼았으면 바로 진료.

근거 · 한국 권고안 2025 · AAOMS 2022

프롤리아를 맞는 분의 치과 계획표

마지막 주사 날짜 하나로 계획이 정해집니다

이럴 때	이렇게 합니다
계획해서 이를 뽑을 때	마지막 주사 뒤 3~4개월 에 — 잘 아물고, 아직 반동이 올 시기는 아닙니다
마지막 주사가 5개월 넘게 지났을 때	더 기다리지 말고, 치과와 내과가 발치 날짜와 다음 주사 날짜 를 함께 빨리 정합니다
많이 아프거나 굼았을 때	시점을 따지지 말고 바로 치료합니다 — 감염을 두는 쪽이 더 나쁩니다
이를 뽑은 뒤 다음 주사	잇몸이 아물면 (보통 6~8주) 맞습니다 — 뼈가 다 찰 때까지 기다리지 않습니다
넘기지 말 선	6개월 정시가 목표 · 7개월 은 넘기지 않기 · 권고안의 마지막 한계선은 총 9개월

Tip · 치과에서 '뼈가 다 찰 때까지 주사 맞지 마세요'라고 하면 내과에 알려 주세요.

근거 · 한국 권고안 2025 · Kim 2024 · Lyu 2020

자주 묻는 두 가지 — 임플란트와 CTX 검사

둘 다 '약을 끊어야 하나'로 이어지는 질문입니다

임플란트, 되나요?

대부분 가능합니다

골다공증 용량이라면 약을 끊지 않고도 심을 수 있다고 봅니다. 다만 위험이 얼마나 되는지는 아직 연구가 충분하지 않아, 치과와 처방 의사가 함께 판단합니다. 암 치료용 고용량 주사를 맞은 분은 이야기가 다릅니다.

시작 전 확인 잇몸병 · 당뇨 · 스테로이드 복용 여부 — 있으면 먼저 정리합니다

CTX 피검사로 안전한 날을 정하나요?

아니요 — 지금은 권하지 않습니다

뼈가 얼마나 활발히 바뀌는지 보는 피검사입니다. 예전에 이 수치로 발치 시점을 정하자는 제안이 있었지만, 맞는 힘이 낮았습니다. 약 이름·마지막 주사일·입안 상태가 더 중요합니다.

34% 기준값 150으로 나뉘었을 때 턱뼈 문제가 생길 분을 미리 맞힌 비율

Tip · 임플란트가 잘 붙는가와 턱뼈 문제가 생기는가는 서로 다른 이야기입니다.

근거 · 임플란트 AAOMS 2022 · CTX JADA 메타분석

치과에 이 네 가지를 알려 주세요

이 네 가지만 정확히 전하면 치과가 판단할 수 있습니다

① 약 이름

‘골다공증약’이라고만 하지 마시고 정확한 이름을 알려 주세요. 약봉투나 처방전을 그대로 보여 주시면 정확합니다.

② 마지막 주사 날짜

프롤리아처럼 6개월마다 맞는 주사는 마지막 날짜가 계획의 출발점입니다. 날짜를 달력이나 휴대폰에 적어 두세요.

③ 얼마나 오래 썼는지

언제부터 얼마나 오래 쓰셨는지, 중간에 바꾼 약이 있는지도 함께 알려 주세요.

④ 골다공증용인지, 암 치료용인지

‘주사 맞아요’만으로는 구분되지 않습니다. 암 치료로 맞는 뼈 주사라면 꼭 말씀해 주세요.

Tip · 약봉투를 휴대폰으로 찍어 두면 치과에서 바로 보여 줄 수 있습니다.

근거 · AAOMS 2022 권고안

다시 보기 · 문의

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

광고바른내과

경기 용인 수지구 광고중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

이 자료의 성격

골다공증 치료 중 치과 치료를 앞둔 분들을 위한 설명자료입니다. 실제 치료 시점과 약 조정은 담당 의사·치과와 상의해 정합니다.

참고한 자료

AAOMS 2022 권고안 · 한국 권고안 2025 · Cummings 2018 · Colella 2023 · Kim 2024 · Lyu 2020 · 휴약
메타분석(8편) · JADA 메타분석



SCAN TO REVISIT

휴대폰에서 다시 보기

QR을 스캔하면 같은 자료를
휴대폰에서 다시 볼 수 있습니다